Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

¿QUÉ ES?

El VIH es un virus que ataca a las células del sistema inmune que ayudan al cuerpo a luchar contra las infecciones, lo que dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer.

DIAGNÓSTICO

PRUEBA #1

Prueba rápida de 3° o 4° generación o ELISA o quimioluminiscencia o prueba en punto de atención. Puede ser de laboratorio, en punto de atención o autotest

- **NEGATIVO**

+

PRUEBA #2

Prueba rápida diferente a la primera, inmunoensayo (ELISA o quimioluminiscencia) o prueba en punto de atención. Realizada/respaldada por laboratorio

- \+ **POSIBLEMENTE POSITIVO** → **INCIAR PROFILAXIS TMI**
- \- → **PRUEBA #3** — **CARGA VIRAL (ARN)**

PRUEBA #3 — CARGA VIRAL (ARN)

- \+ **DETECTABLE** → **POSITIVO**
  - Brindar información
  - Iniciar profilaxis TMI
  - Atención integral
- **INDETECTABLE**
  - Si la 2° prueba fue *negativa*, se considera **NEGATIVO**
  - Si la *2° prueba* fue *positiva*, se **considera NO CONCLUYENTE**

NO CONCLUYENTE → **PRUEBA #4**

PRUEBA #4

- \+ **POSITIVO**
  - Brindar información
  - Iniciar/mantener profilaxis TMI
  - Atención integral
- ? **INDETERMINADO**
  - Mantener profilaxis TMI
  - Repetir algoritmo en 1 mes
- \- **NEGATIVO**
  - Suspender profilaxis TMI
  - Seguimiento trimestral

PREVENCIÓN

TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL ANTEPARTO

- Reducir la carga viral a niveles **indetectables** para disminuir el riesgo de transmisión.

PREFERIDOS

- Dolutegravir (DTG) + tenofovir disoproxil fumarato (TDF) / emtricitabina (FTC)
- Dolutegravir (DTG) + abacavir (ABC)* / lamivudina (3TC)
- Raltegravir (RAL) + tenofovir disoproxil fumarato (TDF) / emtricitabina (FTC)
- Raltegravir (RAL) + abacavir (ABC)* / lamivudina (3TC)

PROFILAXIS ANTIRRETROVIRAL INTRAPARTO

- Cesárea electiva a la semana 38 previo inicio de trabajo de parto o ruptura de membranas
- **Cesarea electiva:** zidovudina IV 3 horas antes del inicio de la cirugía.
- **Parto vaginal:** no amniotomía ni procedimientos invasivos.

PREPARACIÓN DE ZIDOVUDINA PARA INFUSIÓN ENDOVENOSA EN 100 ML DE DEXTROSA AL 5%

Peso de la gestante	Bolo de 2 mg/kg IV aplicar en una hora - Zidovudina N° de gotas	Mantenimiento: 1 mg/kg/hora en infusión continua hasta el parto. Zidovudina N° de gotas
40 kilos	8 ml: 18 gotas/minuto	4 ml: 17 gotas/minuto
50 kilos	10 ml: 18 gotas/minuto	5 ml: 18 gotas/minuto
60 kilos	12 ml: 19 gotas/minuto	6 ml: 18 gotas/minuto
70 kilos	14 ml: 19 gotas/minuto	7 ml: 18 gotas/minuto
80 kilos	16 ml: 19 gotas/minuto	8 ml: 18 gotas/minuto
90 kilos	18 ml: 20 gotas/minuto	9 ml: 18 gotas/minuto

SI NO HAY CONTROLES NI TAMIZAJE PARA VIH, TOMAR PRUEBA RAPIDA EN EL MOMENTO DEL PARTO, SI ES REACTIA E INICIAR ZIDOVUDINA Y PROFILAXIS DE RECIÉN NACIDO.

VÍA DEL PARTO

- Mujer en 3° trimestre con antirretrovirales:
  - Carga viral desconocida o ≥1.000 copias/ml: **cesárea electiva semana 38**.
  - Carga viral <1.000 copias/ml: **parto vaginal**

TRAS EL PARTO

- Supresión farmacológica de lactancia materna (cabergolina)
- Leche de formula (hasta los 12 meses)
- **NO lactancia materna**

RECIÉN NACIDO

- Lavar inmediatamente con agua y jabón tras el parto
- Succión de vía aérea evitando traumatismos
- Profilaxis antirretroviral primeras 6-12 horas de vida (según clasificación de riesgo)
- Seguimiento con cargas virales según GPC

¿CÓMO SE TRANSMITE?

SEXUAL

- Relaciones sexuales penetrativas anales, vaginales u orales sin protección con una persona infectada
- Mayor parte de infecciones.

SANGUÍNEA/PERCUTÁNEA

- Exposición a sangre o derivados, o tejidos transplantados de una persona infectada.
- Lesiones/heridas con elementos contaminados con VIH.

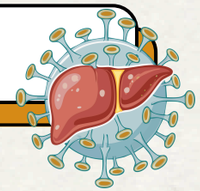
MATERNO INFANTIL

- Madre con VIH a hijo durante la gestación (10%), el parto (70%) o la lactancia (30%).

Neonatos alto riesgo TMI de VIH	Neonatos alto riesgo TMI de VIH
Al menos 1 de los siguientes criterios: • Madres que no recibieron TAR durante la gestación • Madres que solo recibieron TAR intraparto. • Madres que recibieron la TAR anteparto e intraparto, pero con CV detectable cerca al parto (2 – 4 semanas antes). • Madres con infección retroviral aguda durante la gestación • Madres con seroestatus desconocido o con prueba (+) intraparto • Recién nacidos en situación de restablecimiento de derechos con pruebas presuntivas (+) para VIH.	• Madres que recibieron TAR durante la gestación con carga viral NO detectable cerca al parto (2 – 4 semanas). • Si no se cumple este criterio, todos los casos son considerados alto riesgo.

- **Realizado por:** Karent Tatiana Rivera Becerra
- Interna Ginecología y Obstetricia Noviembre 2025

Hepatitis B



ETIOLOGÍA

El Virus de la Hepatitis B (VHB), es un virus ADN, hepatotrópico de la familia hepadnaviridae.
Compuesto por 1 partícula de doble cápsula, con envoltura externa, constituida por el **antígeno de superficie (HBsAg)** y una nucleocápside interna **(core)**. Contiene también un a**ntígeno nuclear (HBcAg)** y **el antígeno e soluble (HBeAg).**

- 90% de Hepatitis B agudas = ASINTOMÁTICAS
- La probabilidad o riesgo de progresión a la cronicidad depende de la edad, el sexo y del estado inmunológico del individuo

¿CÓMO SE TRANSMITE?

SEXUAL

- Relaciones sexuales penetrativas anales, vaginales u orales sin protección con una persona infectada

SANGUÍNEA/PERCUTÁNEA

- Realización de tatuajes o colocación de piercing con material contaminado.
- Uso compartido de jeringas y agujas
- Transfusiones de sangre contaminada.

TRANSMISIÓN HORIZONTAL

- Compartir elementos de aseo personal en el hogar entre personas infectadas y no infectadas.

MATERNO INFANTIL

- **Riesgo depende:** edad gestacional al adquirir la infección, niveles de HBsAg y HBeAg.
- **Transmisión in útero:** rara, amenazas de parto prematuro.
- Transmisión al nacimiento: exposición a sangre y secreciones de la madre
- **Transmisión en la lactancia:** contacto con sangre materna por fisuras o mastitis.

DIAGNÓSTICO

HBSAG Antígeno de superficie

+

Carga viral o HBeAg

- Determinar replicación y necesidad de tratamiento
- Evaluación cirrosis (clínica, pruebas no invasivas como APRI y FIB-4 o ecografía abdominal).
- Tamizar VIH, Hepatitis C y D

-

Considerar repetir en 3° trimestre si hay factores de riesgo

MARCADORES SEROLÓGICOS

Marcador	Interpretación
HBsAg *Antígeno de superficie del VHB*	• Indica presencia del virus • Infección aguda o crónica
Anti- HBs *Anticuerpos dirigidos contra el antígeno de superficie del VHB*	• Inmunidad adquirida contra el VHB por enfermedad o por vacuna.
HBeAg *Antígeno e del VHB*	• Indica replicación viral e infectividad (> replicación = > viremia y > infectividad). • Identifica personas con alta probabilidad de transmitir el VHB.
Anti HBe *Anticuerpos dirigidos contra el antígeno e del VHB*	• Respuesta inmunitaria al *antígeno e* del VHB • Presente con mayor frecuencia en la *fase aguda* de la infección.
HBcAg *Antígeno del core del VHB*	• Solo identificable en bipsia hepática
Anti HBc IgM *Anticuerpos IgM dirigidos contra el Antígeno core del VHB*	• Infección aguda o reciente
Anti HBc IgG *Anticuerpos IgG dirigidos contra el Antígeno core del VHB*	• Infección crónica • Aparecen 6 meses tras la infección
Anti HBc Total *Anticuerpos Totales dirigidos contra el Antígeno core del VHB*	• Infección aguda o crónica • Según fracción elevada (IgG o IgM)

GESTANTE CON VHB

TRATAMIENTO ANTIVIRAL SI:

- Carga viral ≥ 200.000 UI/ml
- Antígeno e (HBeAg) positivo
- Clínica de cirrosis hepática o APRI ≥2
- Coinfección con VIH
- Criterios de inicio de tratamiento según guías en no gestantes.



- Tenofovir 300 mg/día desde **sem 28**
- Entecavir e Interferón NO en embarazo
- **Coinfección VIH:** esquemas con tenofovir

- No contraindicada la **lactancia materna.**
- Educación para evitar lesiones que favorezcan el contagio.

NIÑO EXPUESTO AL VHB

AL MOMENTO DEL PARTO:

- **Vacuna contra la hepatitis B** e **Inmunoglobulina específica para la hepatitis B (HBIG)** en las primeras 12 horas de vida, independientemente del peso al nacer y la edad gestacional.
- Iniciar esquema de vacunación según PAI vigente a los 2 meses de edad

SEGUIMIENTO

- **HBsAg y anti–HBs 3** meses tras finalizar esquema de vacunación, no antes de los 9 meses de edad (evitar detección de anti-HBs de la HBIG aplicada al nacer).

MARCADORES SEROLÓGICOS



HBsAg	Anti-HBs	Interpretación	Conducta
+	-	Caso confirmado Hepatitis B.	Remitir a especialista
-	+	Inmunidad por vacuna o resolución espontánea de infección.	Finalizar seguimiento
-	-	No hubo infección pero tampoco respuesta a la vacuna, riesgo de infección.	2° esquema de vacunación completo

PREVENCIÓN

- Si hay transmisión, el menor tiene 90% de probabilidad de convertirse en paciente crónico con hepatitis B
- Riesgo de 25% de muerte prematura por cáncer de hígado o cirrosis hepática.
- Vacunación en mujeres en edad fértil
- Diagnóstico oportuno y administración temprana de vacuna e inmunoglobulina en el recién nacido + esquema de vacunación de 3 dosis.



- **Realizado por:** Karent Tatiana Rivera Becerra
- Interna Ginecología y Obstetricia Noviembre 2025

Sífilis gestacional y congénita

¿QUÉ ES?

Enfermedad infectocontagiosa y sistémica, exclusiva del ser humano como único reservorio. Causada por la espiroqueta *Treponema pallidum.*

CLASIFICACIÓN CLINICA

- La transmisión sexual de sífilis se clasifica en TEMPRANA y TARDÍA

SIFILIS TEMPRANA

PRIMARIO



- Aparición de una úlcera o chancro en el sitio de la infección

SECUNDARIO



- Erupción cutánea, condilomas planos, lesiones mucocutáneas y linfadenopatías generalizadas.

LATENTE

- **Temprana:** evolución <1 año, asintomática.
- **Tardía:** evolución >1 año

DIAGNÓSTICO

PRUEBA TREPONÉMICA RÁPIDA



- **+** → **INICIAR TRATAMIENTO** → **PRUEBA NO TREPONÉMICA** → **VDRL o RPR**
  - Infección activa o huella inmunológica
  - Define continuidad de tratamiento
- **-** → Vigilancia **trimestral**

SIFILIS CONGÉNITA

Resultado de la transmisión de la infección por vía materno infantil al producto de la gestación.

PRONÓSTICO

- Tasa de eventos negativos (50% - 80%)
- Aborto, muerte neonatal, bajo peso al nacer, prematuridad o infección neonatal, secuelas tardías.

PREVENCIÓN

- Prevención de ITS en la población general y gestante.
- Promoción del uso correcto y consistente del condón.
- Promoción del tamizaje para sífilis en la consulta preconcepcional.
- Realización de pruebas treponémicas y no treponémicas en el control prenatal.
- Tratamiento de la gestante infectada y de sus contactos sexuales.
- Seguimiento a menores hijos de madres con diagnóstico de sífilis.

TRATAMIENTO

Tratamiento según estadio

TEMPRANA

- 1°, 2° y latente temprana
- **2´400.000 UI** de penicilina benzatínica intramuscular, dosis única.

TARDIA

- **2´400.000 UI** de penicilina benzatínica IM, semanal por 3 dosis

TRATAR A COMPAÑEROS SEXUALES

RECIÉN NACIDO

- SIN criterios de caso de **sífilis congénita**

Profilaxis: penicilina benzatínica 50.000 UI/Kg/IM

- CON criterios de caso de **sífilis congénita**
- Diligenciar la ficha de notificación al Sivigila

- **Penicilina G cristalina 100.000 UI/Kg/IV** dividida en dos dosis (**50.000 UI** cada 12 horas por 7 días).
- Luego **150.000 UI/Kg/IV** del día 8 al 10 administrada (50.000 UI/Kg c/d 8 horas).
- Seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL o RPR) a los 3, 6, 9 y 12 meses
- Verificar descenso de los títulos en **2 diluciones**, hasta la negativización o tener títulos **persistentemente bajos** en al menos 2 mediciones separadas con la misma técnica.

COMPROMISO DEL SNC

- Verificar normalidad de parámetros de LCR mediante punción lumbar a los 6 meses de edad.
- Si persisten alterados, recibir nuevamente tratamiento según peso.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

SEXUAL

- Relaciones sexuales penetrativas anales, vaginales u orales sin protección con una persona infectada

SANGUÍNEA

- Contacto de la mucosa o piel erosionada con una lesión infectante

MATERNO INFANTIL

- In útero, transplacentaria, o durante el paso a través del canal de parto
- Entre las semanas 16 y 28 del embarazo
- La probabilidad de transmisión está relacionada con el estadío clínico; aprox. 90% durante el 1° año de la enfermedad sin tratamiento o tratamiento inadecuado.

CRITERIOS SIFILIS CONGÉNITA

Cumple al menos uno de los siguientes:

- Fruto de la gestación de madre con sífilis gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado, sin importar el resultado de la prueba no treponémica (VDRL, RPR) del neonato (al menos 1 dosis de Penicilina benzatínica de 2´400.000 UI IM.
- Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica con títulos 4 veces mayores que los de la madre al momento del parto (2 diluciones por encima del título materno).
- Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo actual, con 1 o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita
- Todo fruto de la gestación con demostración de *Treponema pallidum* por campo oscuro, inmunofluorescencia u otra coloración o procedimiento en lesiones, secreciones, placenta, cordón umbilical o material de autopsia.

- **Realizado por:** Karent Tatiana Rivera Becerra
- Interna Ginecología y Obstetricia Noviembre 2025